

Fecha Última Actualización: 26-05-2022 19:11:53

Página 1 de 4

### Información Paciente

**Nombre** : Lilian Yohana Salazar Romero  
**Edad** : 45a 1m 25d  
**Dirección** : Ejercito Libertador N 0113

**Rut** : 13.151.388-7  
**Fecha Nacto**: 01/04/1977  
**Comuna** : Puente Alto

**N° Archivo** : 9500050  
**Sexo** : Femenino  
**Teléfono** : 966840814

**N° Epicrisis**  
**308316**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Ingreso** : 10/05/2022 02:03

**Días Estadía**: 16

**Unidad de Egreso** : Utim

**Fecha Egreso** : 26/05/2022 19:05

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

EPICRISIS

Identificación:

Nombre: Lilian Salazar Romero  
Edad: 45 años  
RUT: 13151388-7

Cronología:

FI CASR (UEA): 10/05/2022  
FI UPC: 11/05/2022  
FI UTIM: 23/05/2022

Cursando 14avo. día de hospitalización

VMI: 10/05 a 18/05 (9 días)  
PCR COVID: (-) 10/05/2022 (x2)

Antecedentes (obtenidos en ficha clínica y a través de hijo):

Médicos: HTA, fibromialgia, tr. del ánimo, obesidad

Quirúrgicos: Abdominoplastía, cesárea

Fármacos: Enalapril, captopril?, hidroclorotiazida, ác. acetilsalicílico, atorvastatina, paracetamol, metamizol, tramadol, diclofenaco SOS, celecoxib SOS, clonazepam, duloxetine, pregabalina, quetiapina, esomeprazol, domperidona

Alergias: No

Hábitos: TBQ: Muy esporádico, OH: Consumo ocasional, Drogas: No

Inmunizaciones: COVID 2 dosis

Hospitalizaciones: Hijo refiere sin hospitalizaciones previas

Funcionaria CASR (TENS anestesia)

Anamnesis:

Consulta en UEA el día 10/05/2022 por cuadro de aproximadamente 4 días de evolución de tos, cefalea y mialgias, con disnea de evolución progresiva durante las últimas 48 horas hasta reposo. Niega al interrogatorio dirigido fiebre, dolor torácico,

**Fecha Epicrisis** : 26/05/2022 19:11

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 26-05-2022 19:11:53

Página 2 de 4

sintomatología gastrointestinal y sintomatología urinaria. Sin contactos sintomáticos ni contactos con PCR/antígeno (+) para COVID. Ingresa taquicárdica, hipertensa con PAM de 117, con SpO2 88% (15L O2 MNR), se describe taquipneica aunque sin UMA, con crépitos gruesos en ambos campos pulmonares a la auscultación. Se realiza ecoscopia bedside en la que se visualiza VCI pletórica, con líneas b en ambos campos pulmonares, VD < VI, VI hiperdinámico, sin derrame pericárdico. Destaca en exámenes de laboratorio al ingreso discreta elevación de ác. láctico (23.2) parámetros inflamatorios elevados (GB 20080 y PCR 309.1), hiponatremia moderada, hipokalemia leve e hipercloremia, LDH elevada (747) y tropoUS 41.9. AngioTC al ingreso sin evidencias tomográficas de TEP (hasta nivel segmentario), con extensas opacidades parenquimatosas con densidad en "vidrio esmerilado" pulmonares bilaterales. PCR COVID al ingreso negativa (x2). Dado deterioro de mecánica ventilatoria, con PaFi < 100 y CNAF con FiO2 > 90% se decide IOT a las 12 horas de estadía en UEA (10/05 12:30). Paciente al ingreso refiere que no quiere ser intubada, sin embargo, se solicita ev. por psiquiatría de enlace, quienes indican que en contexto de delirium y alteración de curso y contenido del pensamiento no se encuentra en condiciones de decidir/rechazar tratamientos.

Laboratorio al ingreso:

10/05/2022:

Láctico 23.2 TropoUS 41.9

Hcto 36 Hb 12.3 PlaQ 358000 GB 20080 PCR 309.1

Crea 0.94 BUN 19.4 ELP 128/3.09/91

GSV pH 7.41 pCO2 41.2 HCO3 25.5

BT 0.64 BD 0.17 FA 127 GGT 143 SGOT 26 SGPT 14

Alb. 3.9 Ca(C) 9.18 Mg 1.8 Ác. úrico 7.5

LDH 747 Gluc 143

INR 1.09 TTPA 24.7

Imágenes:

AngioTC tórax 10/05/2022:

Impresión:

- Examen sin evidencias tomográficas de un tromboembolismo pulmonar agudo hasta nivel segmentario.
- Extensas opacidades parenquimatosas con densidad en "vidrio esmerilado" pulmonares bilaterales, determinadas por una neumopatía multifocal. Este hallazgo imagenológico es altamente sugerente de neumonía por Covid - 19.
- Aumento del calibre del tronco de la arteria pulmonar, hallazgo que pudiese estar explicado por hipertensión pulmonar.

Diagnósticos de ingreso a UPC:

- Insuficiencia respiratoria aguda
- Infección por SARS-CoV-2 (PCR COVID negativa)
- Neumonía grave por COVID-19
- SDRA moderado

Evolución durante estadía en UPC:

1. Hemodinamia: Al inicio de estadía req. de DVA que suspende, se mantiene estable, sin gatillo TR.
2. Respiratorio: Se mantiene con VMI con parámetros protectores, con despertares agitados que retrasan weaning. Logra extubación el 18/05, actualmente con CNAF.
3. Infectológico: Ingresó en contexto de insuficiencia respiratoria aguda por NAC por COVID-19 grave (diagnóstico imagenológico). Se inicia manejo con corticoides (protocolo Recovery) y al ingreso en IPC se pancultiva.

Intercurrencias infecciosas:

ITU por E. coli MS: Inicialmente ceftriaxona, se rota a Amikacina.

NAVM por SAMS: Inicialmente ceftriaxona, se rota a Cloxacilina.

Bacteremia por S. epidermidis MR: Se interpreta como contaminación (HC positivos 20 - 25 horas)

Evoluciona febril el 19/05 y con alza de parámetros inflamatorios, se cultiva y se indican ATB de amplio espectro (Meropenem/Vancomicina). Posteriormente afebril y con PCR en descenso. Pendiente HC, UC polimicrobiano.

Microbiología:

10/05 PCR COVID (San Gerónimo): Negativo

10/05 PCR COVID (UEA): Negativo

11/05 CAET: S. aureus (R a clindamicina y R a eritromicina)

11/05 HC I y II: S. epidermidis

11/05 SO (inflamatorio), Urocultivo: E. coli MS

Fecha Epicrisis : 26/05/2022 19:11

Página 2 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:14

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 26-05-2022 19:11:53

Página 3 de 4

17/05 C. portación b. productoras de carbapenemasas: Negativo  
19/05 UC: Polimicrobiano  
19/05 H. Cuantitativo de catéter/periféricos: Negativos  
19/05 HC periféricos: Pendientes

4. Psiquiátrico: Cursa con delirium hiperactivo de difícil manejo, controlado con dexmedetomidina, olanzapina, quetiapina, haloperidol y clonazepam). Sin antecedente de uso previo de drogas, en plan de evaluación por psiquiatría de enlace.  
5. Nefrológico: Sin falla renal ni conflicto hidroelectrolítico durante estadía en unidad.  
6. Nutricional: Se indica NE.

Laboratorio 23/05/2022:

Hcto 36 Hb 11.9 Pla 533000 GB 13570 PCR 23.7  
Crea 0.47 BUN 10.4 ELP 137/3.51/105  
GSA pH 7.5 pCO2 35.9 HCO3 27.4  
LDH 526 Gluc 112 CKT 163

Diagnósticos de ingreso a UTIM:

Insuficiencia respiratoria aguda parcial en resolución:

- NAC multilobar por COVID-19

Fiebre en estudio, foco urinario?:

- Con cobertura ATB de amplio espectro

- Sin patógeno aislado

Plan(es):

1. Hemodinamia: Actualmente sin conflicto, sin gatillo TR. En vigilancia.

2. Respiratorio: Hospitalizada en contexto de insuficiencia respiratoria aguda por NAC grave por COVID-19. Al traslado con CNAF; con rápido destete de req. de oxígeno, actualmente a FiO2 ambiental con adecuada mecánica ventilatoria sin disnea.

3. Infectológico: Ingresó en contexto de NAC grave por COVID-19 que requiere IOT (9 días). Finalizó período de aislamiento. Intercurrencias en UPC (NAVM/ITU) y bacteriemia por cocáceas que se interpreta como contaminación (HC positivos a las 20 y 25 horas de procesamiento). Último episodio febril 19/05, sin foco clínico ni patógeno aislado (UC inflamatorio?), HC periféricos pendientes. En vigilancia, control seriado de parámetros inflamatorios, ajuste de ATB según cultivos. Se suspende Vancomicina y continúa con Meropenem, en plan de completar 7 días (finaliza tratamiento hoy).

4. Psiquiátrico: Cursa con delirium de difícil manejo que retrasa weaning. Me comunico con hijo quien refiere tratamiento de tr. del ánimo y de fibromialgia con múltiples fármacos (no logra identificar cuáles utiliza actualmente, menciona los que encuentra en domicilio). Es evaluada en unidad por equipo de psiquiatría, se indica delirium en resolución, e indican suspender olanzapina y mantener con quetiapina y clonazepam.

5. Rehabilitación:

Evaluada por FNA en UPC, se indica régimen 0 por boca. Realizo IC para continuar seguimiento.

Es evaluada por equipo de FNA en unidad, se indica régimen blando (hiposódico) sin granos con líquidos claros, sentada a 90° y pausado, en plan de continuar rehabilitación por equipo.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

Insuficiencia respiratoria aguda parcial resuelta

- NAC multilobar por COVID-19

- Aislamiento finalizado por COVID

Fiebre en estudio, foco urinario?:

- Con cobertura ATB de amplio espectro inicialmente

- Sin patógeno aislado

- Hoy completa curso de Meropenem

Delirium hiperactivo resuelto

INDICACIONES:

Fecha Epicrisis : 26/05/2022 19:11

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 26-05-2022 19:11:53

Página 4 de 4

Reposo: Relativo

Régimen: Blando (hiposódico) sin granos, con líquidos claros, sentada a 90°, pausado

Oxígeno: SOS para SpO2 > 92%

Meropenem 1 gr. cada 8 horas (hoy última dosis 15:00) EV

Paracetamol 1 gr. cada 8 horas VO por 5 días

Duloxetine 30 mg. cada 24 horas VO (AM)

Quetiapina 50 mg. cada 24 horas VO (PM)

Clonazepam 2 mg. cada 24 horas VO (PM)

Omeprazol 20 mg. cada 24 horas VO

Rehabilitación por KNT M y FNA

### Diagnóstico de Egreso

NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA (VIRUS) - NAC grave por COVID

**Condición de Egreso** Alta Hosp. Domiciliaria

**Egreso con Catéter Doble J:** NO

En buenas condiciones generales

Estable desde el punto de vista hemodinámico

Sin apremio respiratorio

Sin uso de musculatura accesoria

Afebril

### Plan Post Alta

INDICACIONES:

Reposo: Relativo

Régimen: Blando (hiposódico) sin granos, con líquidos claros, sentada a 90°, pausado

Oxígeno: SOS para SpO2 > 92%

Meropenem 1 gr. cada 8 horas (hoy última dosis 15:00) EV

Paracetamol 1 gr. cada 8 horas VO por 5 días

Duloxetine 30 mg. cada 24 horas VO (AM)

Quetiapina 50 mg. cada 24 horas VO (PM)

Clonazepam 2 mg. cada 24 horas VO (PM)

Omeprazol 20 mg. cada 24 horas VO

Enalapril 10 mg. cada 24 horas VO

Rehabilitación por KNT M y FNA

### Indicaciones

**Tipo de Reposo** : Relativo

**Régimen Alimentario** : Hiposódico

**Medicamentos** :

### Controles

INTERNO

Becado/Residente



Jhony Gomez Mendoza  
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 26/05/2022 19:11

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:14

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar